

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

eHealth Literacy Scale — Escala de Alfabetización en Salud Electrónica (eHEALS)

Eje VI • Versión de trabajo: 10 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual — Protocolo.pdf en inglés (original CC-BY verificado); ver advertencia sobre versión española no reproducida literalmente

1. Identificación

Familia / sigla	eHEALS
Nombre completo	eHealth Literacy Scale (Norman & Skinner, 2006)
Versión / edición	Original en inglés (8 ítems), verificado íntegramente. Existe validación española (Paramio Pérez et al., 2015) cuyo texto exacto de ítems no se pudo verificar en esta sesión (ver advertencia).
Idioma	Inglés (Protocolo.pdf de este acervo); validación española existente pero no reproducida literalmente aquí.
Autores	Norman CD, Skinner HA.
Año	2006
Tiempo estimado	no verificado

2. Eje y pregunta clínica

Eje primario	EJE VI - SALUD FÍSICA, ESTILO DE VIDA Y MEDICINA CONDUCTUAL
Etiquetas	Alfabetización digital en salud; eHealth literacy; competencia digital; medicina conductual.
Pregunta clínica que responde	¿Qué factores corporales/médicos/conductuales inciden?

3. Constructo, finalidad y usos

Constructo evaluado: percepción del propio conocimiento, comodidad y habilidad para encontrar, evaluar y aplicar información de salud electrónica (Internet) a problemas de salud (alfabetización en salud electrónica).

Finalidad: estimar de forma breve la aptitud percibida de una persona para usar recursos de salud electrónicos, para orientar la idoneidad de recomendar intervenciones o recursos de eHealth y para identificar necesidades de alfabetización digital en salud.

Usos apropiados:

- Evaluación de la alfabetización digital en salud percibida antes de recomendar recursos, aplicaciones o intervenciones de eHealth.
- Investigación sobre brechas digitales en salud y su relación con bienestar psicológico u otras variables.
- Planificación de estrategias de promoción de salud digital adaptadas al nivel de competencia percibida de la población objetivo.

Usos NO apropiados:

- Medida directa de habilidades reales (solo mide percepción/autoinforme de habilidad, no ejecución objetiva).
- Diagnóstico de ningún trastorno; no es una medida clínica de salud mental ni física.
- Evaluación de alfabetización en salud general (no digital): el eHEALS es específico del contexto electrónico/Internet, no sustituye instrumentos de alfabetización en salud general.

4. Población, contexto, informante y modalidad

Población	Adolescentes y adultos; desarrollado originalmente en población juvenil (13-21 años) pero usado ampliamente en adultos en la literatura internacional.
Contexto de aplicación	Salud pública, promoción de salud digital, investigación en eHealth, atención primaria.
Informante	Autoinforme.
Modalidad de administración	Papel y lápiz o formato electrónico; individual.

5. Estructura y administración

Número de ítems	8
Periodo temporal de referencia	no verificado
Formato de respuesta	Likert 5 puntos
Tiempo estimado de aplicación	No verificado en las fuentes consultadas (estimación editorial: 2-3 minutos, dada su brevedad).

6. Dimensiones y puntuaciones

Instrumento unidimensional confirmado tanto en el estudio original (Norman & Skinner, 2006: análisis de componentes principales, solución de un factor, 56% de varianza explicada) como en la validación española (Paramio Pérez et al., 2015: análisis factorial exploratorio y confirmatorio, estructura monofactorial, 52.55% de varianza explicada).

7. Sistema de puntuación

Regla de puntuación	Suma o media de los 8 ítems; mayor puntaje = mayor alfabetización en salud electrónica percibida.
Ítems invertidos	No se identifican ítems inversos en el original inglés verificado; los 8 ítems puntúan en el mismo sentido.
Ítems omitidos / reglas de omisión	No verificado en las fuentes consultadas.
Rango posible / puntos de corte	Rango teórico 8-40 (suma) u 1-5 (media). No se localizaron puntos de corte clínicos de consenso ni en el estudio original ni en la validación española revisada.

8. Evidencia psicométrica en español / LatAm

Original (Norman & Skinner, 2006, N=664 adolescentes canadienses): alfa de Cronbach=0.88; correlaciones ítem-total 0.51-0.76; fiabilidad test-retest modesta ($r=0.40-0.68$ según intervalo). Validación ESPAÑOLA (Paramio Pérez G, Almagro BJ, Hernando Gómez Á, Aguaded JI, 2015, Rev Esp Salud Publica, N=447 universitarios españoles, 18-45 años): alfa de Cronbach=0.87; correlación test-retest=0.78 (30 días); análisis factorial confirmatorio con ajuste adecuado tras correlacionar errores de medida de los ítems 4-7 ($\chi^2/g1=4.44$; CFI=0.97; RMSEA=0.08); invarianza confirmada por sexo; validez de criterio: correlaciones positivas y significativas ($r=0.12-0.16$) con satisfacción con la vida, vitalidad subjetiva y autoestima.

9. Adaptación cultural y norma local

Existe adaptación y validación psicométrica formal en población universitaria española (Paramio Pérez et al., 2015, Universidad de Huelva, publicado en Revista Española de Salud Pública, revista del Ministerio de Sanidad, acceso abierto). El texto EXACTO de los ítems en español está reproducido como imagen/anexo en ese artículo (scielo.isciii.es) y no pudo extraerse como texto verificable con las herramientas disponibles en esta sesión — no verificado literalmente; se recomienda obtener el anexo del

artículo directamente antes de administrar la escala en español. No se verificó adaptación específica para Latinoamérica.

10. Límites clínicos, seguridad, derivación y no-diagnóstico

- El Protocolo.pdf de este acervo reproduce el ORIGINAL EN INGLÉS (fuente verificada palabra por palabra, CC-BY); NO es la versión española validada, cuyo texto exacto de ítems no pudo verificarse en esta sesión (ver advertencia en Fuente_y_uso.md).
- Mide percepción subjetiva de habilidad, no ejecución objetiva de tareas de búsqueda o evaluación de información de salud en línea.
- Desarrollado y validado inicialmente en adolescentes (13-21 años); su aplicabilidad a adultos mayores debe interpretarse con cautela adicional.
- No sustituye una evaluación de competencias digitales objetivas ni de alfabetización en salud general.
- No emplear como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.

11. Titular, licencia y condiciones de reproducción

El artículo original de Norman & Skinner (2006) está publicado bajo licencia Creative Commons Attribution (CC-BY 2.0) en el Journal of Medical Internet Research — reproducción íntegra explícitamente autorizada citando la fuente. El artículo de validación española (Paramio Pérez et al., 2015) está publicado en Revista Española de Salud Pública (Ministerio de Sanidad) bajo licencia CC BY-NC. El Protocolo.pdf de este acervo es una reconstrucción textual verificada del original en inglés (no el binario original, que el entorno de red de este proceso no pudo descargar), con una traducción de trabajo orientativa NO VERIFICADA incluida solo como referencia de contenido.

12. DOI / URL oficiales y referencias APA

Norman CD, Skinner HA (2006). eHEALS: The eHealth Literacy Scale. Journal of Medical Internet Research, 8(4), e27.
<https://doi.org/10.2196/jmir.8.4.e27>

Paramio Pérez G, Almagro BJ, Hernando Gómez Á, Aguaded JI (2015). Validación de la escala eHealth Literacy (eHEALS) en población universitaria española. Revista Española de Salud Pública, 89(3), 329-338.
<https://doi.org/10.4321/S1135-57272015000300010>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

13. Activos disponibles, hash y estado QA

Activos disponibles	Protocolo.pdf (reconstrucción textual verificada con reportlab, 8 ítems en inglés + traducción orientativa no verificada + advertencias). Ficha Tecnica.docx / .pdf.
Hash / verificación	Ver MANIFIESTO_SHA256.csv del proyecto (generado por proceso externo posterior a esta entrega).
Estado QA	Protocolo reconstruido abre correctamente y contiene el texto íntegro verificado (comprobado con pypdf). Requiere revisión humana y localización del anexo español oficial antes de cualquier uso en español.

14. Control de versión

Fecha	2026-08-10
Responsable	Claude — proceso automatizado, requiere revisión humana
Versión de la ficha	1.0